CENTRE HOSPITALIER FICTIF DU BOIS-JOLI
Pôle d'addictologie - 2, allée des Fictifs - 33000 BORDEAUX
Tél. 05 00 12 34 56 Finess 33 0 99997 4

DESMAZURES CORINNE Admission A2212050042
Née le 07/09/1972 (51 ans)
IPP 0081234567 UF 5120 - Addictologie
23 allée des Acacias, 33140 VILLENAVE-D'ORNON

FICHE D'OBSERVATIONS

Observation médicale des urgences du 14/11/2022 (Urgence : Bas)

Validé par VERGNOLLE Romain - Médecin urgentiste le 15/11/2022 à 03:05

Observations :

Patiente de 50 ans amenée par les pompiers pour chute à domicile dans un contexte d'alcoolisation aiguë. Appel de son fils Mathis (19 ans) qui l'a retrouvée au sol dans la cuisine vers 21h.

ATCD : OH chronique, "sevrage en clinique il y a 3 ans" selon le fils. Syndrome dépressif non traité ? Tabac 10 cig/j. Pas de ttt habituel.

Alcoolémie 2,84 g/L à 22h15. GCS 14. Hématome frontal G, pas de PC rapportée. Douleur + déformation poignet G.

Radio : fracture extrémité inf. du radius G non déplacée. TDM cérébrale : pas de saignement.

Conclusions :

IEA avec chute. Fracture radius G : immobilisation plâtrée, avis ortho demain. Surveillance UHCD jusqu'à dégrisement.

Proposition de rencontre avec l'ELSA, patiente d'accord "si ça peut aider".

Observation ELSA du 15/11/2022 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 16/11/2022 à 06:00 par MONTEIL Gwenaëlle

Rencontre de Mme DESMAZURES à l'UHCD à la demande des urgences. Pateinte calme, un peu honteuse, dit "je bois pour dormir depuis le divorce".

Consos : vin rosé, 1,5 à 2 bouteilles/jour, plus le week end. Premiere conso le matin vers 10h, tremblements matinaux +. Pas de crise convulsive ni de DT connus.

Tabac : dit etre non fumeuse.

Sevrage antérieur : clinique des Pins en 2019, "tenu 4 mois".

Vit seule depuis le départ de sa fille Léa pour ses études, son fils Mathis passe "un week end sur deux". En arret de travail (AS en EHPAD) depuis septembre.

Cushman 2 ce matin (6 à 8h selon les collegues de nuit).

Accepte une hospitalisation pour sevrage programmé. Tel pour la recontacter : 06 71 48 22 09.

Conclusions :

Inscription sur liste d'attente sevrage. RDV consult addicto avec le Dr LAFFITTE le 24/11.

Consultation psychiatrique addictologie du 24/11/2022 (Urgence : Bas)

Validé par LAFFITTE Hortense - Psychiatre addictologue le 24/11/2022 à 18:31

Observations :

Première consultation. Adressée par l'ELSA après passage aux urgences le 14/11 (IEA, chute, fracture du radius G).

Histoire des consommations : premières ivresses à l'adolescence, usage festif jusqu'à la trentaine. Usage quotidien installé vers 2015, aggravé après le divorce (2016). Un sevrage hospitalier en 2019 (clinique des Pins), abstinence de 4 mois, puis reprise progressive.

Actuellement 10 à 12 UIA/j, consommation matinale, perte de contrôle, abandon des activités. Trouble de l'usage de l'alcool sévère (8 critères DSM-5).

Tabac 10 cig/j. Pas d'autre produit, pas de BZD hors prescription.

Thymie : tristesse, anhédonie partielle, sommeil fragmenté avec réveils précoces, culpabilité vis-à-vis des enfants. Pas d'idées suicidaires actuelles. Un passage à l'acte en 2016 (IMV, non hospitalisée) au moment de la séparation. Évaluation thymique à refaire à distance du sevrage.

Contexte : divorcée, 2 enfants (Léa 23 ans, Mathis 19 ans). Ex-mari M. Thierry DESMAZURES, relations conflictuelles. Sœur Mme Valérie PELLETIER, soutenante. Mère âgée, malade (cancer du pancréas).

Biologie des urgences : GGT 312, VGM 104, ASAT/ALAT 98/54.

Conclusions :

TUAL sévère, symptomatologie dépressive à réévaluer après sevrage.

Sevrage résidentiel programmé le 05/12/2022 (10 jours). Thiamine dès maintenant. Pas d'antidépresseur pour l'instant.

Observation médicale d'entrée du 05/12/2022 (Urgence : Bas)

Dernière modification le 05/12/2022 à 16:47 par ROCHEREAU Camille - Interne

Observations :

Entrée programmée pour sevarge d'alcool chez une patiente de 50 ans suivie par le Dr LAFFITTE.

FICHE D'OBSERVATIONS

Dernière consommation ce matin à 7h ("un verre pour pouvoir conduire jusqu'ici", ce qui pose question concernant la conduite automobile, à rediscuter avec elle). La patiente rapporte une consommation d'environ 1 litre de vin par jour depuis "une dizaine d'années", soit depuis 2012-2013, avec une nette majoration au moment du divorce qu'elle situe en 2017.
Pas d'antécédent de convulsions ni de délirium tremens. Tabagisme actif estimé à 15 paquets-années.
À l'examen : TA 152/94, FC 104, sueurs, tremblements des extrémités, Cushman 7. Plâtre de l'avant-bras G en place (fracture du radius du 14/11).
Sur le plan thymique, la patiente apparaît triste, pleure à l'évocation de ses enfants et de sa mère hospitalisée. Je retiens plutôt un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive dans ce contexte, mais une dépression caractérisée n'est pas exclue.
Conclusions :
Sevrage par diazépam selon protocole Cushman (40 mg à J1), thiamine 500 mg/j IV pendant 3 jours puis per os, hydratation. Surveillance Cushman toutes les 4h. Bilan : NFS, iono, BHC, TP, CDT. Échographie hépatique à prévoir.

Observation infirmière du 06/12/2022 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 07/12/2022 à 06:00 par TESSIER Ghislaine
Nuit agitee. Pte reveillee a 1h, sueurs ++, tremblements, dit voir "des petites betes sur le mur" puis critique. Cushman 11 a 1h -> diazepam 20mg selon protocole, Cushman 6 a 3h. TA 158/96. Hydratation PO ok.
Rassurée, s'est rendormie vers 3h30. Appel au med de garde (Dr NAVARRO) : pas de modif du ttt, surveillance rapprochée.

Observation médicale de suivi du 07/12/2022 (Urgence : Bas)

Validé par ROCHEREAU Camille - Interne le 07/12/2022 à 17:10
Observations :
J3 du sevrage. Hallucinations visuelles transitoires cette nuit (cf. transmissions IDE), critiquées, sans désorientation : pas d'argument pour un DT. Cushman 4 ce matin. Décroissance du diazépam : 30 mg/j.
Bilan biologique : GGT 287, VGM 103, TP 78 %, plaquettes 132 G/L, CDT 4,1 %.
La patiente se dit "soulagée d'être là". Évoque un premier sevrage "en 2018 ou 2019", elle ne sait plus.
Conclusions :
Poursuite de la décroissance. Introduction de l'acamprosate à discuter en fin de séjour. Échographie abdominale demandée.

Entretien psychologique du 12/12/2022 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIGHI Solène - Psychologue le 13/12/2022 à 09:02
Premier entretien. Mme Desmazures parle facilement, avec beaucoup d'émotion. Elle situe le "début de la descente" au départ de son mari, qu'elle décrit comme un homme "froid, qui comptait chaque centime". Elle dit avoir "tenu pour les enfants" jusqu'à ce que sa fille parte faire ses études.
L'alcool est décrit comme un "anesthésiant" : le soir d'abord, puis "dès que la maison est vide". Forte culpabilité vis-à-vis de son fils, qui l'a retrouvée au sol.
Elle évoque sa mère, hospitalisée, avec qui la relation est ambivalente ("elle ne m'a jamais dit qu'elle était fière de moi").
Bonne capacité d'élaboration. Demande un suivi après la sortie, qu'elle souhaite "plutôt en TCC, pour avoir des outils".
Proposition : suivi psychologique au CSAPA après la sortie, un entretien tous les 15 jours.

Observation médicale de sortie du 16/12/2022 (Urgence : Bas)

Validé par LAFFITTE Hortense - Psychiatre addictologue le 16/12/2022 à 12:40
Observations :
Sevrage mené à terme sans complication majeure (hallucinations visuelles transitoires à J2, sans DT). Arrêt du diazépam ce jour. Cushman 0.
Thymie : persistance d'une tristesse, d'une anhédonie et de réveils précoces malgré l'arrêt de l'alcool. Pas d'idées suicidaires.
Échographie : stéatose hépatique homogène, pas de signe d'hypertension portale.
Conclusions :

Sortie ce jour. Traitement : acamprosate 333 mg 2-2-2, thiamine 250 mg/j. Contrôle ortho le 20/12.
Suivi au CSAPA : consultation psychiatrique le 10/01/2023, psychologue (Mme ARRIGHI) tous les 15 jours, IDE hebdomadaire.
Courrier au médecin traitant (Dr FOURCADE).

Entretien social du 03/01/2023 (Urgence : Bas)

Validé par CASTAING Odile - Assistante sociale le 05/01/2023 à 11:15
Entretien à la demande de Mme DESMAZURES pour sa situation professionnelle et financière.
Aide-soignante à l'EHPAD Les Glycines (CDI), en arrêt maladie depuis le 12/09/2022. IJ versées avec 2 mois de retard.
Découvert bancaire important. Pension alimentaire non versée par l'ex-mari depuis l'été.
Mme DESMAZURES évoque des fêtes de fin d'année difficiles : elle a passé Noël chez sa sœur, où elle "a bu quelques verres de champagne puis n'a pas pu s'arrêter" le 25 au soir. Elle n'a pas osé en parler à l'équipe.
Elle souhaite reprendre le travail "le plus tôt possible".
Démarches : courrier à la CPAM pour régulariser les IJ, visite de pré-reprise auprès du médecin du travail, information sur le recouvrement de la pension (CAF / ARIPA).
Prochain RDV le 17/01/2023.

Consultation psychiatrique addictologie du 10/01/2023 (Urgence : Bas)

Validé par LAFFITTE Hortense - Psychiatre addictologue le 10/01/2023 à 13:02
Observations :
Revue 3 semaines après la sortie. Dit être abstinente depuis la sortie le 16/12, avec un craving important en soirée. Bonne observance de l'acamprosate.
Thymie : humeur triste, anhédonie, aboulie, ralentissement, insomnie de fin de nuit, perte de 4 kg en 2 mois. Ces symptômes persistent après 3 semaines d'abstinence : en faveur d'un épisode dépressif caractérisé d'intensité moyenne, plutôt que d'un trouble de l'adaptation. Pas d'idées suicidaires.
Ablation du plâtre ce jour en orthopédie.
Conclusions :
EDC d'intensité moyenne. TUAL sévère en début de rémission.
Introduction de sertraline 50 mg/j. Poursuite de l'acamprosate. GGT de contrôle. RDV dans 1 mois.

Observation infirmière CSAPA du 24/01/2023 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 25/01/2023 à 06:00 par MONTEIL Gwenaëlle
Pte vue pour ctrl bio + entretien. GGT 198 (287 en dec.) : en baisse mais pas normalisée. Dit avoir "craqué une fois à Noël" mais rien depuis. Ethylotest 0,00. Pas de tremblements.
Tolère bien la sertraline, un peu nauséeuse les premiers jours.
Fume 10 cig/jour, voudrait arreter "mais pas maintenant".

Consultation psychiatrique addictologie du 21/02/2023 (Urgence : Bas)

Validé par LAFFITTE Hortense - Psychiatre addictologue le 21/02/2023 à 16:20
Observations :
Craving persistant. Deux épisodes de consommation début février (vin, "une bouteille" à chaque fois), sans reprise quotidienne. Acamprosate jugé peu efficace par la patiente.
Thymie un peu meilleure, sommeil amélioré. Sertraline 50 mg bien tolérée.
Conclusions :
Arrêt de l'acamprosate, relais par baclofène : 10 mg x3/j, augmentation de 10 mg tous les 3 jours, objectif 60 mg/j à réévaluer. Informée des effets indésirables (somnolence, vertiges) et de la contre-indication à la conduite pendant la titration.
RDV dans 3 semaines.

Entretien psychologique du 10/05/2023 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIGHI Solène - Psychologue le 10/05/2023 à 18:45
Séance marquée par le décès de sa mère, survenu "il y a une dizaine de jours". Mme Desmazures dit ne pas avoir eu le

temps de "se réconcilier". Elle a beaucoup pleuré aux obsèques et décrit une envie de boire "énorme", à laquelle elle a résisté "grâce à Léa qui dormait à la maison".
Travail sur le deuil et sur les situations à risque (soirées seule, dimanches).
Elle dit prendre le baclofène "à 50" et ne pas avoir bu depuis "début mars".

Consultation psychiatrique addictologie du 13/06/2023 (Urgence : Bas)

Validé par LAFFITTE Hortense - Psychiatre addictologue le 13/06/2023 à 12:05
Observations :
Aggravation thymique depuis le décès de sa mère fin avril. Ruminations, culpabilité, insomnie. Idées de mort passives ("parfois je me dis que ce serait plus simple de ne pas se réveiller"), sans projet ni scénario, critiquées. Facteurs de protection : ses enfants.
Abstinence d'alcool maintenue depuis mars selon la patiente. Baclofène 60 mg/j (20-20-20), bien toléré.
Conclusions :
Augmentation de la sertraline à 100 mg/j. Numéro du 3114 donné. Consultations rapprochées (tous les 15 jours).
Poursuite de la psychothérapie.

Observation infirmière CSAPA du 15/06/2023 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 16/06/2023 à 06:00 par MONTEIL Gwenaëlle
Appel tel de la pte : nausées et diarrhées depuis l'augmentation de la sertraline a 150mg (?). Verif ordonnance : 100 mg prescrits. La pte avait mal compris, prenait 3 cp de 50. Explications données, plan de prise réécrit. Rappel prévu demain.

Consultation psychiatrique addictologie du 19/09/2023 (Urgence : Bas)

Validé par LAFFITTE Hortense - Psychiatre addictologue le 19/09/2023 à 11:30
Observations :
Nette amélioration. Thymie normalisée, sommeil réparateur. Reprise du travail en mi-temps thérapeutique depuis le 04/09/2023 à l'EHPAD, "contente de retrouver les collègues".
Abstinence complète depuis mars 2023 (6 mois), CDT normale, GGT 54.
Tabac réduit à 5 cig/j, envisage des substituts nicotiniques.
Conclusions :
TUAL en rémission précoce. EDC en rémission partielle. Poursuite sertraline 100 mg et baclofène 60 mg. Patchs nicotiniques 14 mg/24h. RDV dans 2 mois.

Observation infirmière CSAPA du 23/01/2024 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 24/01/2024 à 06:00 par LAMOTHE Guy-Noël
Mme DESMAZURE venue sans RDV, en pleurs. A rebu depuis 10 jours environ, "tous les soirs", jusqu'à 6 verres de vin. Déclencheur : départ de son fils Mathis pour Toulouse (formation) début janvier, la maison est vide. Pas d'alcoolisation matinale pour l'instant. Ethylotest 0,32 g/L à 16h.
A arreté le baclofène "depuis Noël" car "ça ne servait plus à rien".
Pas d'idée suicidaire exprimée. Vu avec dr laffitte : RDV avancé au 25/01.

Consultation psychiatrique addictologie du 25/01/2024 (Urgence : Bas)

Validé par LAFFITTE Hortense - Psychiatre addictologue le 25/01/2024 à 17:50
Observations :
Reprise des consommations depuis la mi-janvier 2024 ("depuis les fêtes" selon la patiente), 4 à 6 UIA/j le soir, pas de consommation matinale, pas de signe de sevrage. Arrêt du baclofène fin décembre, de sa propre initiative.
Thymie : tristesse réactionnelle, pas d'éléments en faveur d'une rechute dépressive franche. Sertraline poursuivie.
Conclusions :
Rechute du TUAL sans dépendance physique à ce stade. Reprise du baclofène avec titration jusqu'à 60 mg/j. Objectif de réduction puis d'abstinence discuté : la patiente préfère "réduire d'abord". Suivi IDE hebdomadaire, psychologue maintenue. RDV dans 3 semaines.